DATO DE ATENCIÓN URGENCIA (DAU)

ESTABLECIMIENTO	HOSPITAL SAN CARLOS	N°DAU	3583547
CALIDAD	Original	FECHA	10/04/2024 16:10
AREA	U.E. Adulto	BOX	Camilla
HC	2009365669	CTA. CTE.	0

DATOS CONSULTANTE:

Nombre : JOSE ISMAEL SALDAÑA CARRIEL **RUN** : 5.104.066-K **CP** : 513492
Previsión : FONASA B **F.Nac** : 10/02/1944 **Género** : Masculino **Edad** : 80 Años 2 Meses 1 Días
Dirección : LA GLORIA **Comuna** : NIQUEN **Teléfono** : 967010201

DATOS INGRESO:

Procedencia : SAN GREGORIO (CESFAM) **Mot. Consulta** : MORBILIDAD COMUN
Lug. Ocurrencia : NO_ESPECIFICADO **Med. Llegada** : AUTO PARTICULAR

SELECTOR DEMANDA: 1° llamado: 10/04/2024 16:15:11;

Profesional : LORENA VASQUEZ ORTEGA **Hra. Llamada** : 10/04/2024 16:15 **Hora Atención** : 10/04/2024 16:22
T° Axilar : 0 **T° Rectal** : **Presión** : **Pulso** : 94 **Frec. Resp.** : 0
Saturometría : 92 **HGT** : **Peso** : **Glasgow** : **Clasificación** : C3
Motivo de consulta: : ENVIADO DESDE POSTA LA GLORIA NEUMONIA V/S ITU. ALZA FEBRIL EN DOMICILIO, POLIMIALGIA.
AM: HTA, DLP, ARTROSIS, ITU RECURRENTE, HBP OPERADO, SECUELA MOTORA EEII POR TEC ANTIGUO
ALERGIA: NO
FC 94 SAT 92% T 37.7

CONTROL SIGNOS VITALES:

Fecha	Pulso	Presión	T° Axilar	T° Rectal	FR	Sat.	HGT	Profesional
10/04/2024 16:46	90	113/58				95		Doris Lidia belmar muñoz
10/04/2024 19:29	105	141/87	36.9			94		JACQUELINE VILLANUEVA SILVA
11/04/2024 01:46	91	140/78	36.4			95	135	LILIANA LOPEZ VALENZUELA

ACCIDENTE, ALCOHOLEMIA Y/O TOXICOLOGIA:

INFORME LESIONES : NO **INFORME ALCOHOLEMIA:** : NO

ANAMNESIS:

Fecha	Anamnesis	Profesional
10/04/2024 18:40	AM: HTA, Hemiparesia izq secundario a TEC complicado. Fcos: ENL 10mg/dia, OMP 20mg/dia, Quetiapina 50mg/noche. Alergia: No Paciente derivado de Posta la gloria por cuadro de 1 dia de evolucion, caracterizado por CEG, orinas oscuras, tos y fiebre cuantificada hasta hasta 39°C, con tendencia a la hipotension. Cuenta con ant de ITUs a repeticion, multiresistentes.	GONZALO ANDRÉS CARRASCO LOBO
10/04/2024 20:49	OC: Inflamatoria Crea: 0.8 BUN: 57 PCR: 296 Leuco: 9.000 - Segmentados: 83% - Linfocitos: 8 % - Monocitos: 8% Rx de Tx: Patrón intersticial bilateral. Presenta refuerzo de imagen en zona pleural derecha.	GONZALO ANDRÉS CARRASCO LOBO
10/04/2024 23:03	Pendiente informe de TAC de Tx	GONZALO ANDRÉS CARRASCO LOBO
11/04/2024 01:21	Informe scanner TAC tórax C/C extensas placas pleurales en tercio medio e inferior del hemitórax derecho que se asocia a masa de densidad partes blandas delimitada por calcificaciones laminares aparentemente en espacio pleural basal derecho, sin evidencia realce significativo tras el uso de contraste. Atelectasias pasivas Secuelas pleuroparanquemitosas en ambos vértices de predominio derecho Saturacion O2: 94%	cristian Argote Echeverria

EXAMEN FÍSICO :

Fecha	Examen Físico	Profesional
10/04/2024 18:40	CLOTE MP (+) sibilancias. bilaterales. Llene cap <2 seg.	GONZALO ANDRÉS CARRASCO LOBO

DIAGNÓSTICOS: **Condición de ingreso:** Conciente

Fecha	Hipótesis diagnóstica	Profesional
11/04/2024 01:21	Derrame pleural crónico loculado	cristian Argote Echeverria
10/04/2024 21:02	N39.0 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	GONZALO ANDRÉS CARRASCO LOBO
11/04/2024 01:21	J22.X INF. AGUDA NO ESPECIF. VIAS RESPIRATOR.INFERIORES.	cristian Argote Echeverria

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS (TRATAMIENTO EN BOX):

Fecha	Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos	Profesional	Estado	Responsable
10/04/2024 18:40	Laboratorio	GONZALO ANDRÉS CARRASCO LOBO	Ejecutado el 10/04/2024 19:18	LORENA VASQUEZ ORTEGA Obs:IE SEBASTIAN ROJAS
10/04/2024 18:40	Rx de Tx AP y Lateral	GONZALO ANDRÉS CARRASCO LOBO	Ejecutado el 10/04/2024 18:58	Maritza Yasmin Biernay Morales
10/04/2024 20:48	Ceftriaxona 2g EV	GONZALO ANDRÉS CARRASCO LOBO	Ejecutado el 10/04/2024 21:07	Elizabeth Fierro Palma Obs:IE NATACHA SÁNCHEZ UBB
10/04/2024 21:08	TAC de Tx c/c	GONZALO ANDRÉS CARRASCO LOBO	Ejecutado el 11/04/2024 01:01	Natalia Iris Valentina Muñoz Martínez
10/04/2024 23:05	Recontrol de SV	GONZALO ANDRÉS CARRASCO LOBO	Ejecutado el 11/04/2024 01:46	LILIANA LOPEZ VALENZUELA
11/04/2024 01:25	ALTA	cristian Argote Echeverria	Ejecutado el 11/04/2024 01:40	Paz Valentina Del Solar Reveco

EXAMENES:

Fecha	Examen	Profesional
10/04/2024 18:40	RCTO GLOBULAR ; UREMIA ; CREATININEMIA ; E.L.P. ; PCR ; ORINA COMPLETA ; OTROS ;	GONZALO ANDRÉS CARRASCO LOBO
10/04/2024 18:41	RX T?RAX FRONTAL Y LATERAL,TC. T?RAX CON CONTRASTE	Gonzalo Andrés Carrasco Lobo

INDICACIONES ALTA:

Fecha	Indicación	Profesional

11/04/2024 01:21	tto sintomatico HODOM signos de alarma control SOS comunicar novedades Ceftriaxona 2 gr EV c/24h por 10 días paracetamol 500 mg 2 comp VO c/12h por 3 dias metamizol 300 mg 1 comp VO c/8h por 3 dias (fiebre) rescate de urocultivo en 3 dias derivacion desde consultorio a Broncopulmonar para estudio de derrame pleural derecho cronico entrego hoja DAU	cristian Argote Echeverria

RECETAS:

Fecha	Prescripción	Profesional
11/04/2024 01:23	Ceftriaxona 2 gr EV c/24h por 10 días paracetamol 500 mg 2 comp VO c/12h por 3 dias metamizol 300 mg 1 comp VO c/8h por 3 dias (fiebre)	cristian Argote Echeverria

OBSERVACIONES:

Fecha	Indicación	Profesional
10/04/2024 16:46	CSV INTERNA TENS DEYANIRA CONTRERAS VIRGINIO GOMEZ.	Doris Lidia belmar muñoz
10/04/2024 19:21	PACIENTE REFIERE NO PODER ORINAR, AL DAR LA OPCION DE SONDEARLO, HIJO LA RECHAZA.	LORENA VASQUEZ ORTEGA
11/04/2024 01:01	Impresión: Extensa secuela retráctil pleuroparenquimatosa del hemitórax derecho asociado a placas pleurales calcificadas y aparente derrame pleural crónico loculado. Un elemento proliferativo local pleuroparenquimatoso no se puede descartar. Correlacionar con antecedentes médicos. Requiere control evolutivo y eventual complemento histológico. Signos vasculares de hipertensión pulmonar. Ateromatosis aórtica y coronaria. Tiroides de aspecto nodular. Correlacionar con ultrasonido.	Natalia Iris Valentina Muñoz Martínez
11/04/2024 01:40	Dirección Cruce La Gloria/Tiuquilemu Teléfonos de contacto 967010201 Carlos Aranda 988229685 Teresa Mella	Paz Valentina Del Solar Reveco

GES : No **PERTINENCIA** : Si **DESTINO** : Domicilio

ADVERTENCIA
ESTE ES UN DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO Y SÓLO UNA PRIMERA ATENCIÓN. DEBE CONSULTAR A SU CENTRO DE SALUD O MÉDICO TRATANTE DENTRO DE LAS 12-24 HORAS SIGUIENTES. SI SUS SÍNTOMAS EMPEORAN, CONSULTE NUEVAMENTE A LA BREVEDAD. ES SU RESPONSABILIDAD SEGUIR ESTAS INDICACIONES.

LLAME A SALUD RESPONDE
600•360•7777
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

cristian Argote Echeverria
27.394.692-6